

La chronologie des soins

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre pourquoi une chronologie datée de vos soins est la première pièce que réclament un avocat et un médecin-conseil. - Remplir vous-même, ligne par ligne, un tableau clair qui reconstitue tout votre parcours médical, du premier rendez-vous à aujourd'hui. - Repérer les moments sensibles de votre prise en charge, sans les qualifier vous-même, grâce à un exemple entièrement rédigé.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi la chronologie change tout

Quand une prise en charge médicale se passe mal, vous gardez d'abord des souvenirs. Une douleur, une inquiétude, une phrase entendue dans un couloir. Ces souvenirs comptent, mais ils ne suffisent pas. Un dossier de responsabilité médicale se construit sur des faits datés, pas sur des impressions. La chronologie des soins transforme votre vécu en une matière que le droit et la médecine peuvent examiner.

Une chronologie, c'est simplement la liste ordonnée de tout ce qui vous est arrivé, dans l'ordre du calendrier. Chaque ligne porte une date, un lieu, un professionnel et un acte. Mise bout à bout, cette liste raconte votre parcours mieux que n'importe quel récit. Elle montre ce qui a été fait, quand, par qui, et ce qui a changé pour vous ensuite.

Cette pièce est la colonne vertébrale de l'expertise médicale. L'expertise médicale est l'examen conduit par un médecin, souvent désigné par une commission ou par un juge, pour évaluer vos lésions, vos séquelles et le lien entre vos soins et votre état. L'expert ne connaît pas votre histoire. Il la reconstitue à partir de pièces. Une chronologie claire lui fait gagner un temps précieux et l'empêche d'oublier un épisode important.

Elle sert aussi votre avocat et votre médecin-conseil. Le médecin-conseil est le médecin qui vous assiste, discute l'évaluation de vos préjudices et lit votre dossier avec un œil technique. Lui et votre avocat cherchent une chose : le manquement possible, c'est-à-dire l'acte ou l'absence d'acte qui n'aurait pas dû se produire. Ce manquement se cache toujours dans un intervalle de temps. Un retard de diagnostic, un signe négligé, une information non donnée. Sans dates précises, ces intervalles restent invisibles.

La loi elle-même raisonne en dates. En matière de responsabilité médicale, les actions se prescrivent par 10 ans à compter de la consolidation du dommage, selon l'article L1142-28 du code de la santé publique. La consolidation est le moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus. Savoir dater vos épisodes de soins vous aide à situer ce point de départ et à ne pas laisser filer un délai.

Enfin, la chronologie protège votre mémoire. Les mois passent, les visages se confondent, les ordonnances se perdent. Un dossier médical peut compter des centaines de pages. En posant chaque fait sur une ligne datée dès maintenant, vous fixez la vérité pendant qu'elle est encore fraîche. Vous vous épargnez, plus tard, l'épuisement de tout reconstituer sous pression.

Le tableau à remplir, colonne par colonne

Voici l'outil. Un simple tableau à six colonnes, que vous complétez une ligne par événement. Un événement, c'est un rendez-vous, une hospitalisation, un examen, une opération, un appel, la remise d'une ordonnance. Notez tout, même ce qui vous semble mineur. Un détail anodin pour vous peut être décisif pour un médecin-conseil.

Date	Lieu	Praticien	Acte réalisé	Information reçue	Votre état après l'acte
Le jour, le mois, l'année. Ajoutez l'heure si vous la connaissez.	L'établissement ou le cabinet, avec la ville.	Le nom et la spécialité, si vous les avez.	Ce qui a été fait : consultation, examen, opération, prescription.	Ce que le professionnel vous a dit, expliqué, ou remis par écrit.	Comment vous vous sentiez ensuite : douleur, fièvre, amélioration, aggravation.

Chaque colonne a une raison d'être précise. Prenez le temps de comprendre ce qu'elle sert, car c'est ce qui distingue une chronologie utile d'une simple liste.

La date. C'est le cœur du tableau. Une date exacte vaut mieux qu'une approximation, mais une approximation vaut mieux que rien. Si vous hésitez, écrivez «vers le 12 mars» plutôt que de laisser vide. Vos justificatifs vous aideront à préciser ensuite. Regardez vos ordonnances, vos comptes rendus, vos relevés de sécurité sociale et vos messages : ils sont tous datés.

Le lieu. Un même parcours passe souvent par plusieurs établissements. La clinique où l'on vous a opéré, le cabinet de ville qui suit, le service d'urgences où vous êtes retourné. Distinguer les lieux permet de savoir qui détenait votre dossier à chaque étape, et à qui adresser une demande de communication.

Le praticien. Notez le nom quand vous le connaissez, sinon la fonction : «l'anesthésiste», «le chirurgien de garde», «l'infirmière du service». La responsabilité en médecine est personnelle ou attachée à un établissement. Savoir qui a fait quoi est donc essentiel, sans que vous ayez à désigner un coupable.

L'acte réalisé. Décrivez sobrement le geste ou la décision. «Pose d'une prothèse de hanche droite». «Prescription d'un antibiotique». «Radiographie de contrôle». Vous n'avez pas à employer le vocabulaire médical exact. Vos mots suffisent, votre médecin-conseil traduira.

L'information reçue. Cette colonne est souvent la plus négligée, et pourtant l'une des plus importantes. Notez ce qu'on vous a dit des risques, des alternatives, des suites attendues. La loi impose au professionnel de vous informer, et c'est à lui de prouver qu'il l'a fait, selon l'article L1111-2 du code de la santé publique. Ce que vous consignez ici, à chaud, éclaire plus tard une question délicate : avez-vous été préparé à ce qui est arrivé.

Votre état après l'acte. Décrivez ce que vous avez ressenti dans les heures et les jours qui ont suivi. Une fièvre, une douleur nouvelle, un écoulement, une gêne qui s'installe. C'est cette colonne qui fait apparaître les enchaînements. Un acte, puis un signe, puis un autre acte. La médecine et le droit lisent votre histoire dans ces enchaînements.

Un conseil de méthode. Remplissez le tableau au calme, en plusieurs fois, avec vos documents sous les yeux. Ne cherchez pas à interpréter. Vous décrivez, vous ne jugez pas. La qualification viendra plus tard, et elle appartient à d'autres. Votre travail, précieux, est de rendre les faits complets et exacts.

Où retrouver vos dates

La date exacte vous semble parfois perdue. Elle ne l'est presque jamais. Votre parcours a laissé partout des traces datées, et il suffit de les rassembler. Voici les sources les plus fiables, à réunir avant de remplir le tableau.

Vos ordonnances portent la date de chaque consultation et le nom du prescripteur. Vos comptes rendus d'hospitalisation et opératoires indiquent les dates d'entrée, d'intervention et de sortie. Vos résultats d'analyses et vos comptes rendus d'imagerie sont horodatés au jour près. Vos convocations, vos courriers entre médecins et vos bulletins de situation complètent l'ensemble.

Deux sources sont souvent oubliées, alors qu'elles sont très sûres. Vos relevés de l'assurance maladie, consultables sur votre compte, listent chaque acte remboursé avec sa date et le professionnel concerné. Vos agendas, vos messages et vos courriels contiennent des rappels de rendez-vous qui confirment une date hésitante.

Réunissez ces pièces dans un dossier unique, papier ou numérique, et numérotez-les. Cette organisation vous servira deux fois : d'abord pour dater votre chronologie, ensuite pour la transmettre à votre avocat sans rien avoir à rechercher dans l'urgence. Ne jetez jamais un document médical, même ancien, même illisible à vos yeux. Un compte rendu que vous ne comprenez pas peut être une pièce maîtresse pour un médecin-conseil.

Si des pièces vous manquent, vous pouvez réclamer votre dossier médical complet à chaque établissement. La marche à suivre fait l'objet d'un autre document du kit. Ne bloquez pas votre chronologie pour autant : commencez avec ce que vous avez, et complétez au fur et à mesure que les documents arrivent.

Un exemple entièrement rédigé : l'infection après une prothèse de hanche

Pour rendre l'outil concret, voici une chronologie complète. Elle est fictive, mais construite comme un vrai dossier. Les noms, les dates et les lieux sont illustratifs. Suivez le fil : une patiente, Madame Martin, se fait poser une prothèse de hanche, puis développe une infection. Observez comment le tableau fait remonter les moments qui méritent une question.

Date	Lieu	Praticien	Acte réalisé	Information reçue	Votre état après l'acte
8 janvier 2026	Cabinet d'orthopédie, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien orthopédiste	Consultation pour douleurs de hanche. Diagnostic d'arthrose évoluée. Indication d'une prothèse totale de hanche droite.	«L'opération est très courante. Vous marcherez mieux.» Aucun risque particulier détaillé par écrit.	Soulagée par la perspective, mais douleur quotidienne persistante.
22 janvier 2026	Laboratoire, Aix-en-Provence	Infirmière préleveuse	Bilan sanguin préopératoire.	Résultats à apporter le jour de l'hospitalisation.	Aucun changement.
5 février 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr B., anesthésiste	Consultation d'anesthésie obligatoire.	Explications sur l'anesthésie. Remise d'un document sur le jeûne.	Aucun changement.
3 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien	Pose de la prothèse totale de hanche droite. Intervention notée sans incident au compte rendu.	«Tout s'est bien passé.»	Douleur post-opératoire attendue. Fièvre légère le soir même.
4 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Infirmières du service	Surveillance, pansement, premier lever.	Consignes de rééducation.	Douleur vive. Température à 38,2 degrés notée au dossier.
6 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien	Visite avant la sortie.	«La fièvre est normale après une opération.» Sortie autorisée.	Cicatrice rouge, chaude. Fièvre persistante à la maison.
12 mars 2026	Cabinet de ville, Salon-de-Provence	Médecin traitant	Consultation pour fièvre et écoulement de la cicatrice.	«Cela peut arriver.» Prescription d'un antibiotique par la bouche.	Écoulement clair par la cicatrice. Fièvre à 38,5 degrés.
19 mars 2026	Cabinet de ville, Salon-de-Provence	Médecin traitant	Consultation de contrôle. État non amélioré.	Conseil de contacter le chirurgien.	Douleur croissante, difficulté à poser le pied.
21 mars 2026	Clinique du Parc, Aix-en-Provence	Dr A., chirurgien	Examen de la cicatrice. Prélèvement de l'écoulement pour analyse.	«On attend les résultats du laboratoire.»	Fièvre à 39 degrés le lendemain.
24 mars 2026	Laboratoire de la clinique	Biologiste	Analyse du prélèvement. Identification d'un staphylocoque doré.	Résultat transmis au chirurgien.	État général altéré, frissons.
25 mars 2026	Centre hospitalier, Marseille	Dr C., service des maladies infectieuses	Hospitalisation en urgence. Diagnostic d'infection du site opératoire sur prothèse.	«L'infection touche la prothèse. Une reprise chirurgicale est nécessaire.»	Alitée, sous antibiotiques par perfusion.

Date	Lieu	Praticien	Acte réalisé	Information reçue	Votre état après l'acte
28 mars 2026	Centre hospitalier, Marseille	Dr D., chirurgien orthopédiste	Première reprise chirurgicale : lavage articulaire, prélèvements profonds.	«Nous nettoyons, nous gardons la prothèse pour l'instant.»	Douleur intense, hospitalisation prolongée.
15 avril 2026	Centre hospitalier, Marseille	Dr D., chirurgien orthopédiste	Seconde reprise : ablation de la prothèse infectée, pose d'un espaceur.	Explication d'une seconde prothèse dans plusieurs mois.	Perte d'autonomie, marche impossible sans aide.
2 mai 2026	Centre hospitalier, Marseille	Équipe soignante	Sortie avec antibiotiques prolongés et aide à domicile.	Rendez-vous de suivi programmés.	Autonomie très réduite, moral atteint, aide humaine quotidienne.

Cette chronologie tient sur une page. Elle raconte pourtant quatre mois d'une vie bouleversée. Lisez-la maintenant comme le ferait un médecin-conseil.

Plusieurs points appellent une question, sans qu'aucun ne soit, à ce stade, la preuve d'une faute. C'est justement ce que la chronologie permet : voir où regarder.

Le premier point sensible apparaît le 8 janvier. La colonne «information reçue» ne mentionne aucune explication écrite des risques, notamment le risque d'infection. Or l'infection est un risque connu de la chirurgie prothétique. La loi impose au professionnel d'informer le patient des risques graves normalement prévisibles, et c'est à lui de prouver qu'il l'a fait. Le défaut d'information, lorsqu'il existe, peut ouvrir droit à la réparation d'un préjudice propre, appelé préjudice d'impréparation. La Cour de cassation l'a consacré dans un arrêt de principe du 23 janvier 2014. Ce n'est pas à vous de trancher. Vous notez simplement l'absence, et vous laissez le juriste l'apprécier.

Le deuxième point sensible se lit dans l'enchaînement des 3, 4 et 6 mars. Une fièvre le soir de l'opération, une température élevée le lendemain, une cicatrice rouge et chaude à la sortie. Puis une sortie autorisée malgré ces signes. Un médecin-conseil se demandera si ces signaux d'alerte ont été correctement interprétés, ou si une surveillance plus longue s'imposait. La chronologie ne répond pas à cette question. Elle la rend visible.

Le troisième point sensible court du 12 au 24 mars. Presque deux semaines s'écoulent entre les premiers signes d'infection et l'identification du germe. Ce délai peut être médicalement justifié, ou non. Seule l'analyse du dossier complet le dira. Mais sans chronologie datée, ce délai passerait inaperçu. Avec elle, il saute aux yeux.

Le quatrième point touche la nature même de l'infection. Une infection contractée à l'occasion des soins, qui n'existait pas avant l'entrée dans l'établissement, porte un nom précis : l'infection nosocomiale. En droit, les établissements de santé répondent des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, selon l'article L1142-1 du code de la santé publique. C'est un régime particulier, plus favorable à la victime que la faute classique. Savoir dater précisément l'apparition de l'infection, après l'opération et non avant, devient alors déterminant. Votre chronologie fournit exactement cette datation.

Voyez ce que l'outil a produit. Une patiente qui gardait des souvenirs douloureux dispose maintenant d'une pièce solide. Elle n'a accusé personne. Elle a décrit. Et sa description, à elle seule, indique à son avocat et à son

médecin-conseil les quatre endroits précis où creuser.

Ce que la chronologie ne fait pas

Il faut être clair, car votre prudence vous protège. La chronologie prépare votre dossier. Elle ne le juge pas. Repérer un point sensible n'est pas prouver une faute. Un délai peut avoir une explication médicale légitime. Une fièvre peut être banale. Une information non écrite a pu être donnée oralement.

La qualification d'une faute est un travail technique et juridique. Elle suppose de confronter votre chronologie au dossier médical complet, aux données de la science et aux règles de responsabilité. Ce travail revient à un avocat, épaulé par un médecin-conseil. Eux seuls peuvent dire si un manquement existe, s'il vous a causé un dommage, et selon quel fondement le faire valoir.

Cette répartition des rôles est une force, pas une limite. Vous apportez la matière première, précise et honnête. Les professionnels apportent l'analyse. Une chronologie exacte mais neutre a bien plus de poids qu'un récit accusateur et flou. Résistez donc à la tentation d'ajouter des commentaires ou des conclusions dans votre tableau. Laissez les faits parler.

Pour bâtir cette chronologie, vous aurez besoin de votre dossier médical. La loi vous en garantit l'accès. Toute personne peut obtenir communication des informations de santé la concernant, au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande, ce délai étant porté à 2 mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans, selon l'article L1111-7 du code de la santé publique. Ce dossier confirmera et complétera vos souvenirs. Un autre document du kit vous guide, pas à pas, pour le demander.

Enfin, une voie amiable existe avant tout procès. Toute personne s'estimant victime d'un dommage lié à des soins peut saisir une commission de conciliation et d'indemnisation, la CCI, dont la saisine suspend les délais de prescription, selon l'article L1142-7 du code de la santé publique. Là encore, votre chronologie sera la première pièce utile. Mais le choix de cette voie, comme celui d'un procès, se décide avec un avocat.

Lexique des termes employés

Chronologie des soins. Liste ordonnée et datée de tous les événements de votre parcours médical, du premier rendez-vous à aujourd'hui, qui sert de base à l'analyse de votre dossier.

Consolidation. Moment où votre état de santé se stabilise et n'évolue plus, à partir duquel on mesure les séquelles définitives et d'où court le délai de prescription.

Expertise médicale. Examen conduit par un médecin désigné, souvent par une commission ou un juge, pour évaluer vos lésions, vos séquelles et le lien entre vos soins et votre état.

Imputabilité. Lien de cause à effet entre un acte de soin et votre dommage, que le médecin-conseil et l'expert cherchent à établir à partir des faits datés.

Infection nosocomiale. Infection contractée à l'occasion des soins, absente avant votre prise en charge, dont l'établissement répond sauf s'il prouve une cause étrangère.

Médecin-conseil. Médecin qui vous assiste, lit votre dossier avec un regard technique et discute l'évaluation de vos préjudices, en face du médecin de l'assureur ou de l'expert.

Préjudice d'impréparation. Préjudice propre né du défaut d'information sur un risque, lorsque ce risque se réalise et que vous n'y aviez pas été préparé, reconnu par la Cour de cassation.

Prescription. Délai au-delà duquel une action n'est plus recevable. En responsabilité médicale, il est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage.

CCI (commission de conciliation et d'indemnisation). Instance amiable que peut saisir toute personne s'estimant victime d'un dommage lié aux soins, dont la saisine suspend les délais de prescription.

Votre prochaine étape Ouvrez un tableau vierge à six colonnes et posez dès aujourd'hui les dates dont vous êtes certain, en vous appuyant sur vos ordonnances et vos comptes rendus. Complétez le reste au fil de vos documents.

Un accompagnement si vous le souhaitez

Une fois votre chronologie posée, une lecture par des professionnels lui donne toute sa valeur. La SELARL LEXVOX AVOCATS, dont Me Patrice Humbert est spécialiste du dommage corporel, accompagne les victimes d'accidents médicaux dans toute la région PACA, avec une première consultation de 30 minutes gratuite. Si un moment de votre parcours vous interroge, vous pouvez nous en parler avant d'engager quoi que ce soit.